内科学含诊断学 循环系统疾病

高血压急症 二狭 → 急性左心衰 → 硝普钠 禁用

核心精讲·收缩性心衰

（性感认识：急性心衰减负荷、慢性心衰抗重构）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

各种导致心脏功能和结构异常的疾病终末阶段即心力衰竭（heart failure,HF），此时心排血量不能满足机体组织代谢需要→器官组织血液灌注不足：

①绝对灌注不足：如急性心梗

②相对灌注不足：如甲亢 组织耗氧代谢↑,虽心脏射血没有减少甚至增高,但仍然没有办法满足机体需求

高排量心衰 动脚评价人（动静脉瘘 脚气病 贫血 甲亢 妊娠）

一、根据左心室射血分数（left ventricular ejection fraction,LVEF）

LVEF	类型
≤40%	射血分数降低的心衰 HFrEF（reduced）/收缩性心衰⭐
41-49%	射血分数轻度降低型心衰 HFmrEF（mildly）
≥50%	射血分数保留型心衰 HFpEF（preserved）/舒张性心衰 收缩功能没有下降
既往≤40%、在治疗过程发现＞40%	射血分数改善的心衰 HFimpEF（improved）

二、心衰评定

心功能不全（无症状） 充血性心衰（有症状）

1.分期

A 心衰危险因素阶段	只有心衰高危因素（冠心病、高血压等）
B 前心衰阶段（心功能不全）	无心衰临床表现 有心脏结构改变（左心室肥厚、心瓣膜病、既往心肌梗死、脑钠肽升高等） 室壁张力↑(牵拉心肌细胞)
C 症状性心衰阶段	**有心衰临床表现**
D 晚期心衰阶段	心源性恶病质（大量体脂、蛋白质丢失致干重下降）

无症状心衰：代偿

异长调节

①左室收缩↓→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑→搏出量可维持正常（Frank-Starling 机制）

②LVEF（搏出量/心室舒张末期容积）↓，伴神经内分泌激活 只要搏出量减少就会激活交感、RAAS

正常 增加

对于心室功能减退患者,LVEF比搏出量更敏感反映射血功能减退

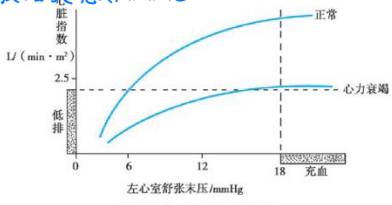


图 3-2-1 左心室功能曲线

VS CCS分级 200米 一层楼

2.**NYHA 分级**（注意：急性心梗致心衰用 Killip 分级、陈旧心梗用 NYHA 分级）

1无23啰4休克

I

II 一般活动出现呼吸困难等心衰症状（NYHA II级相当于 **C** 期）

III 夜间憋醒、需坐起后缓解（躺下去坐起来）

IV 躺都躺不下去、查体半卧位

端坐呼吸≠NYHA IV｛躺都躺不下去,这种端坐呼吸是IV级 / 躺下去再坐起来,这种端坐呼吸就是III级｝

3.慢性心衰分度：**6 分钟步行＜150m、150-450m、＞450m→重、中、轻度**（150+450=6 分钟）